REALIZAÇÃO
Sala de Situação de Saúde - UnB
Residência de Vigilância em Saúde

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO | PUBLICADO EM 3 DE NOVEMBRO DE 2026

SE 43 2026

Semana Epidemiológica

25 a 31 de outubro de 2026

8 EIXOS TEMÁTICOS

30 ANÁLISES

RESUMO DA SEMANA

A SE 43 de 2026 foi marcada pelo fortalecimento do El Niño, com anomalias acima de 3 °C no Pacífico central e leste e projeção de até 3,8 °C entre novembro e janeiro. Na Índia, o ciclone Arnab atingiu Andhra Pradesh em 28 de outubro, com 4 óbitos e 28 mil pessoas desabrigadas. No Brasil, a seca grave alcança 28% do Nordeste e 8% do Norte, 307 municípios estão em alerta alto de risco de fogo e 70 polos-base indígenas enfrentam seca severa, enquanto Brasília manteve PM2,5 médio de 7,4 µg/m³, sem dias insalubres. A vigilância sentinela identificou 47.440 vírus respiratórios no país, e o Brasil soma 7.137 óbitos por SRAG até a SE 42; no DF, os casos de SRAG subiram 5,9% nas SE 39 a 42, e Guajará lidera a incidência de SRAG no Amazonas. O município do Rio de Janeiro acumula 167 casos confirmados de mpox. A dengue soma 25.611 casos prováveis no país nas SE 39 a 42, Goiás registra 6.564 e o DF acumula 3.652 casos prováveis no ano, e a chikungunya cresce 35,1% em Mato Grosso do Sul. Nas Américas, o sarampo chega a 56.978 casos e 83 óbitos, e o Brasil confirma 61 casos, sem nenhuma região com a meta de cobertura da segunda dose. A epidemia pelo vírus Bundibugyo na República Democrática do Congo ultrapassa 10 mil casos confirmados, atinge 67 zonas de saúde e soma 10 casos no Quênia e na Nigéria. O DF ampliou a vacinação contra influenza a toda a população a partir de 6 meses, e a Pensilvânia (EUA) emitiu alerta sobre sarampo congênito.

NESTA EDIÇÃO

1 **Alerta ambiental** 3
5 análises | Risco 2

2 **Síndrome gripal e SRAG** 8
5 análises | Risco 2

3 **Cobertura vacinal** 13
1 análise | Risco 0

4 **Mpox** 14
2 análises | Risco 4

5 **Arboviroses** 16
5 análises | Risco 2

6 **Sarampo** 21
7 análises | Risco 4

7 **Ebola** 27
3 análises | Risco 4

8 **Atualidades** 31
2 análises

1 Alerta ambiental

RISCO 2

Inundação, chuva, seca e queimada

OMM projeta anomalia de até 3,8 °C no Pacífico tropical entre novembro de 2026 e janeiro de 2027 sob o El Niño

+3,8 °C	> 3 °C	+2,08 °C
anomalia prevista no Pacífico tropical, nov a jan	anomalias no Pacífico central e leste em 26/10	anomalia de setembro, a 2ª maior desde 1950

O El Niño de 2026, confirmado em junho, ganhou força sem interrupção e já registra anomalias de temperatura do mar acima de 3 °C no Pacífico central e leste (26 de outubro). A Organização Meteorológica Mundial (OMM) projeta anomalia de até 3,8 °C no Pacífico tropical entre novembro e janeiro, valor que supera os picos de 1997-1998 e de 2015-2016, os eventos mais intensos da série histórica, e coloca o fenômeno em patamar inédito. Em setembro, a anomalia de 2,08 °C já havia sido a segunda maior desde 1950. Os efeitos sobre a saúde variam conforme a região. Onde a seca predomina, como na África Austral, no Sudeste Asiático, na América Central, no sul do Caribe e na Amazônia, aumentam a insegurança alimentar, a desnutrição e os incêndios florestais. Onde chove acima do normal, como na África Oriental, na América do Norte e no norte do Caribe, aumentam os surtos de cólera, malária e febre do Vale do Rift, como ocorreu em 1997-1998. O cenário indica um verão austral de alto risco climático e sanitário em vários continentes ao mesmo tempo, com impacto esperado sobre doenças infecciosas e mortalidade por doenças cardiovasculares.

11/06	Setembro	Outubro	26/10	Nov a jan
El Niño confirmado (+0,7 °C)	+2,08 °C, segunda maior anomalia desde 1950	+2,4 °C (dado semanal)	Mais de 3 °C no Pacífico central e leste	+3,8 °C, pico previsto

Fonte: OMM e NOAA.

Ciclone Arnab atinge Andhra Pradesh, na Índia, em 28 de outubro de 2026 e deixa 28 mil pessoas desabrigadas

150 km/h	28 mil	4
rajadas de vento	pessoas desabrigadas	óbitos em Andhra Pradesh

Em 28 de outubro, o ciclone Arnab atingiu a costa de Andhra Pradesh, no leste da Índia, com rajadas de até 150 km/h, e houve alerta vermelho para chuva extremamente forte em cinco distritos do sul de Odisha. O El Niño altera os padrões globais de ventos e de temperatura dos oceanos e cria condições de instabilidade atmosférica e águas mais quentes, que alimentam tempestades como ciclones. Quatro óbitos é um número baixo para um ciclone muito severo e reflete a política indiana de evacuação preventiva, consolidada após o superciclone de Odisha, em 1999, que deixou cerca de 10 mil mortos. A retirada preventiva da população, com 28 mil pessoas desabrigadas, e a transferência antecipada de gestantes para hospitais mostram a integração entre defesa civil e saúde. Foram registrados danos a casas, estradas e à rede elétrica, falta de energia e de água potável e áreas baixas alagadas, e um navio com seis tripulantes ficou à deriva. O risco agora

está na fase pós-impacto: abrigos superlotados favorecem doenças respiratórias; a falta de água potável e as áreas alagadas aumentam o risco de doenças diarreicas, leptospirose e arboviroses; e a falta de energia compromete a rede de frio das vacinas e o funcionamento dos serviços de saúde. (Figura 1)

A Imagem de satélite do ciclone (NOAA)



B Danos causados pelo ciclone (foto: Reuters)



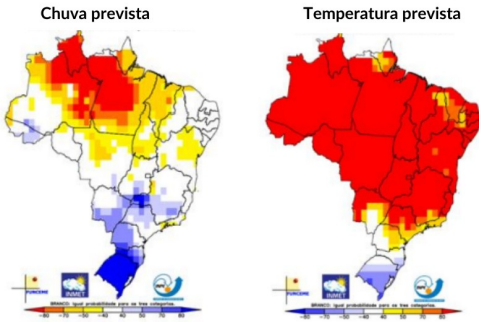
Figura 1. Imagem de satélite do ciclone Arnab (NOAA) e danos causados em Andhra Pradesh (foto: Reuters)
Fonte: NOAA e Newsonair.

Seca grave atinge 28% do Nordeste e 8% do Norte do Brasil em outubro de 2026, e El Niño deve trazer chuva acima da média ao Sul

28%	**8%**	**68**	**270+**
do Nordeste em seca grave	do Norte em seca grave	municípios em seca extrema em outubro	alertas hidrológicos no Sul em 2026
eram 16%	**eram 4%**	**eram 4 em agosto**	

A previsão para novembro a janeiro segue o padrão clássico do El Niño no Brasil: mais chuva no Sul, déficit hídrico no Norte e no Nordeste e calor acima do normal em quase todo o país. A seca grave atinge 28% do Nordeste, contra 16% no levantamento anterior, e 8% do Norte, o dobro do registrado antes (4%). Pelo Índice Integrado de Seca, os municípios em seca extrema passaram de 4 em agosto para 68 em outubro (dado parcial). No Sul, mais de 270 alertas hidrológicos emitidos em 2026 indicam bacias já saturadas, o que aumenta o risco de inundações, leptospirose, doenças diarreicas e acidentes com animais peçonhentos, como se viu no Rio Grande do Sul em 2024. No Norte e no Nordeste, a falta de água piora a qualidade da água consumida, favorece doenças de veiculação hídrica e aumenta a exposição à fumaça e ao calor extremo. (Figura 2)

A Chuva e temperatura previstas, nov a jan (vermelho: chuva abaixo ou temperatura acima da média; azul: chuva acima ou temperatura abaixo)



B Municípios por classe do Índice Integrado de Seca (IIS), agosto e outubro (parcial)

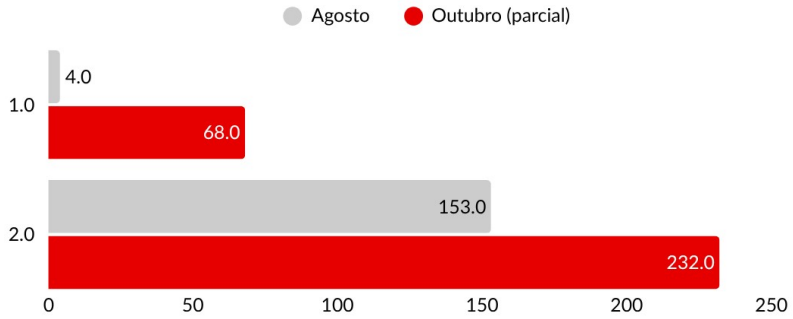


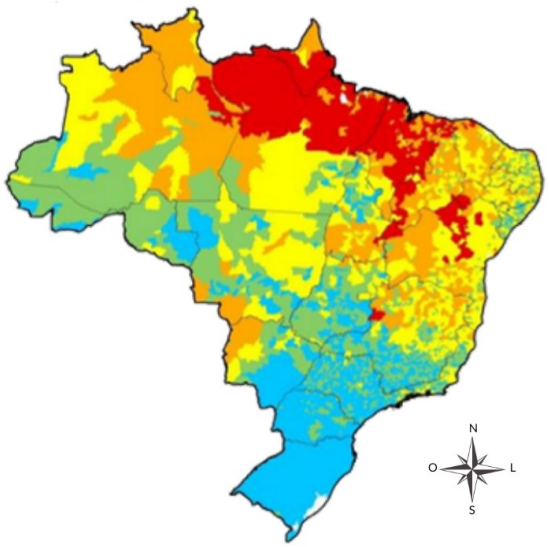
Figura 2. Previsão de chuva e de temperatura para novembro de 2026 a janeiro de 2027 e municípios brasileiros por classe do Índice Integrado de Seca (IIS), agosto e outubro de 2026

Fonte: INMET e Cemaden.

Brasil tem 307 municípios em alerta alto de risco de fogo para novembro de 2026 a janeiro de 2027, sobretudo na Região Norte

307	48	24	70
municípios em alerta alto de risco de fogo	municípios em emergência no Amazonas	municípios em emergência no Pará	polos-base indígenas em seca severa, cerca de 86 mil pessoas

A Região Norte concentra o maior risco de fogo previsto para o trimestre de novembro a janeiro: no país, 307 municípios estão em alerta alto e 464 em alerta. O cenário repete as secas extremas de 2023 e 2024, quando o rio Negro atingiu as menores cotas já registradas em Manaus. O Amazonas tem 48 municípios em situação de emergência e o Pará, 24, o que motivou repasse federal de R$ 68,6 milhões para a região. Na Amazônia, a seca vai além do abastecimento de água, porque os rios são as estradas: a vazante isola comunidades, interrompe o transporte de insumos, vacinas e pacientes e dificulta a remoção de casos graves. Os 70 polos-base indígenas em seca severa (34 em Roraima, 33 no Amazonas e 3 no Amapá), com cerca de 86 mil pessoas, formam o grupo mais vulnerável, com maior risco de insegurança alimentar, desnutrição infantil, doenças diarreicas pelo consumo de água imprópria e problemas respiratórios causados pela fumaça. (Figura 3)



Nível de Alerta	Número de municípios	Área (km²)
Alerta alto	307	1,183,614
Alerta	464	1,779,586
Atenção	1336	2,222,735
Observação	1306	1,944,771
Baixa probabilidade	2135	1,355,273

Figura 3. Risco de fogo previsto para novembro de 2026 a janeiro de 2027, por nível de alerta, Brasil
Fonte: INMET e Cemaden.

Brasília registra média de PM2,5 de 7,4 µg/m³ entre 30 de setembro e 30 de outubro de 2026, sem dias insalubres

7,4 µg/m³	0	5 µg/m³
média de PM2,5 em Brasília no período **queda de 22%**	dias com qualidade do ar insalubre	diretriz anual da OMS

Entre 30 de setembro e 30 de outubro, a concentração de partículas finas (PM2,5) no Distrito Federal ficou abaixo do limite diário de 15 µg/m³ recomendado pela Organização Mundial da Saúde em todos os dias, sem registro de dias classificados como insalubres. A média do período em Brasília, de 7,4 µg/m³, é 22% menor que a da análise anterior. A queda é compatível com o início da estação chuvosa, que reduz os focos de queimada e ajuda a remover as partículas da atmosfera; os valores mais altos se concentraram na primeira quinzena de outubro, ainda no fim da estiagem. Mesmo assim, a média supera a diretriz anual da OMS, de 5 µg/m³, e não existe nível seguro de exposição ao PM2,5. A exposição contínua está associada a doenças respiratórias e cardiovasculares, com maior impacto em crianças, idosos e pessoas com asma. Com o El Niño, temperaturas elevadas e veranicos podem trazer novos picos de poluição. (Figura 4)



Figura 4. Concentração diária de PM2,5, Brasília (DF), 30 de setembro a 30 de outubro de 2026, com faixas de concentração segundo a diretriz da OMS

Fonte: IQAir.

2 Síndrome gripal e SRAG

RISCO 2
Humanos

Vigilância sentinela de síndrome gripal identifica 47.440 vírus respiratórios no Brasil até a SE 42 de 2026

47.440	60%	45%	37%
vírus respiratórios identificados	rinovírus entre os outros vírus	influenza B entre os casos de influenza	influenza A(H3N2) entre os casos de influenza

A vigilância sentinela de síndrome gripal identificou 47.440 vírus respiratórios no Brasil até a SE 42 de 2026. A distribuição percentual permaneceu igual à da semana anterior: 70% dos vírus detectados correspondem a outros vírus respiratórios e 30% à influenza. Entre os outros vírus, o rinovírus segue como o mais detectado (60%), seguido pelo vírus sincicial respiratório (VSR, 16%). Entre os casos de influenza, a influenza B responde por 45% e a influenza A(H3N2) por 37%. Ao longo do ano, o rinovírus foi o vírus mais frequente em todas as semanas. A influenza A(H3N2) teve maior peso no início do ano, com pico entre as SE 9 e 11, e depois perdeu espaço. A influenza B ganhou destaque a partir da SE 19, manteve alta circulação até cerca da SE 28 e vem diminuindo desde então. O VSR aumentou entre as SE 19 e 26 e segue em queda. O SARS-CoV-2 manteve baixa detecção, com números pequenos em todo o período. (Figura 5)

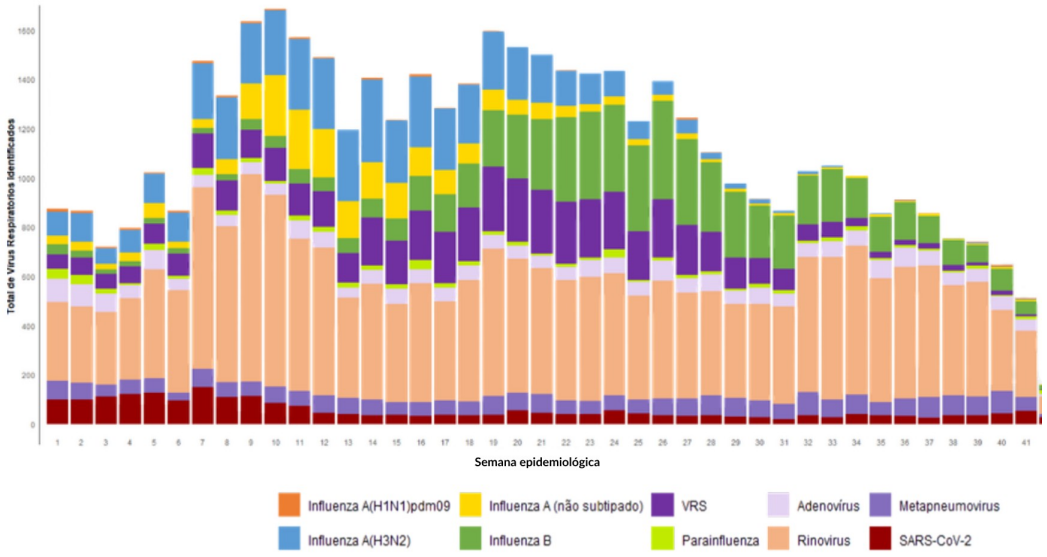


Figura 5. Vírus respiratórios identificados na vigilância sentinela de síndrome gripal, por SE, Brasil, 2026 até a SE 42
Fonte: Ministério da Saúde.

Brasil registra 7.137 óbitos por SRAG entre 163.252 casos confirmados até a SE 42 de 2026

163.252
casos de SRAG confirmados
alta de 1,6%

7.137
óbitos por SRAG
alta de 2,3%

Até a SE 42 de 2026, o Brasil registrou 7.137 óbitos por SRAG entre 163.252 casos confirmados. Em relação à semana anterior, os casos aumentaram 1,6% e os óbitos, 2,3%. A mortalidade se concentra nas pessoas com 65 anos ou mais, faixa em que as detecções virais nos óbitos são sobretudo influenza A (não subtipada e H3N2), rinovírus e covid-19. Entre os menores de 2 anos, predominam o VSR e o rinovírus. As últimas semanas apresentam números baixos, que ainda tendem a ser atualizados e devem ser interpretados com cautela; o aumento da proporção de óbitos por covid-19 nas SE 41 e 42 reflete o pequeno número de óbitos com resultado já registrado. (Figura 6)

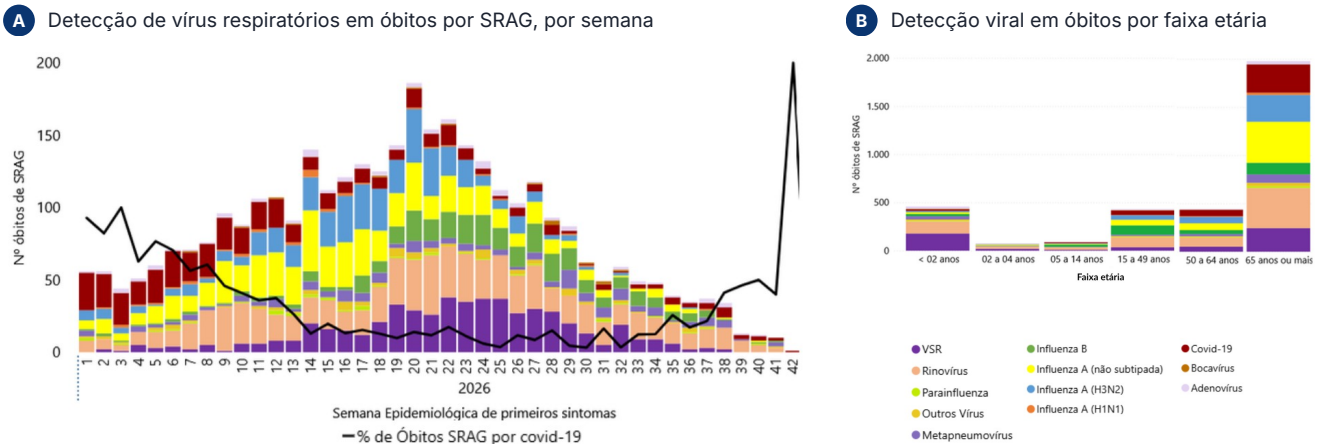


Figura 6. Detecção de vírus respiratórios em óbitos por SRAG, por SE e por faixa etária, Brasil, até a SE 42 de 2026
Fonte: Ministério da Saúde.

Vigilância sentinela do Distrito Federal registra predomínio de SARS-CoV-2 na SE 42 de 2026, com poucas amostras processadas

43 (91%)
amostras processadas na SE 41

23 (45%)
amostras processadas na SE 42

4 (44%)
amostras processadas na SE 43

No Distrito Federal, a distribuição percentual dos vírus respiratórios causadores de síndrome gripal identificados pela vigilância sentinela em 2026 mostra padrão relativamente estável ao longo do ano. O rinovírus foi o vírus mais identificado em praticamente todas as semanas, seguido pela influenza B, que ganhou destaque a partir da SE 17 e se mantém presente, e pela influenza A não subtipada. O VSR e o adenovírus aparecem em menor proporção. O metapneumovírus, que teve participação importante até cerca da SE 13, ainda não voltou a aumentar. Já o SARS-CoV-2 aumentou nas últimas semanas, com participação maior entre as SE 40 e 42, e chegou a predominar na SE 42. As semanas mais recentes, porém, têm menos amostras processadas: na SE 41 foram coletadas 47 amostras e processadas 43 (91%); na SE 42, coletadas 51 e processadas 23 (45%); e na SE 43, coletadas 9 e processadas 4 (44%). Com poucas amostras, a proporção de cada vírus oscila bastante, e a predominância do SARS-CoV-2 na SE 42 está baseada em apenas 23 amostras. (Figura 7)

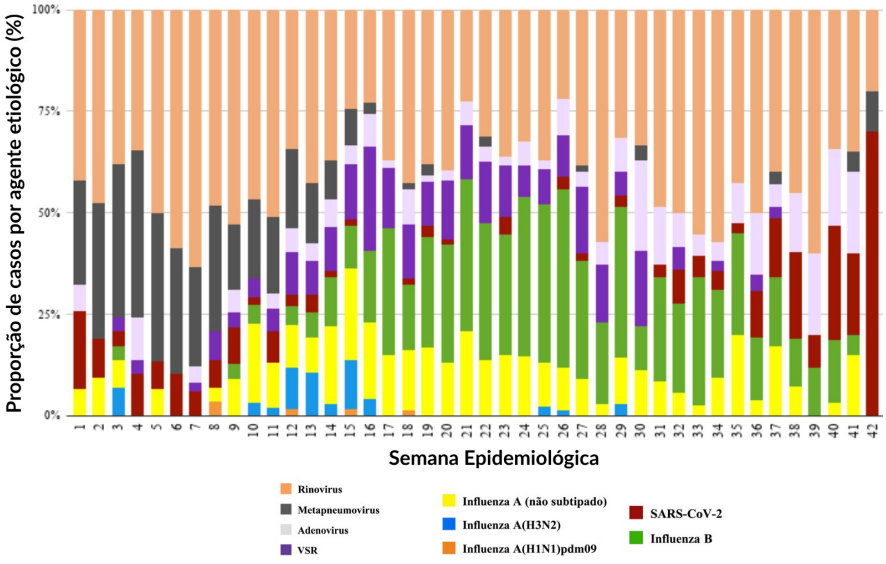


Figura 7. Distribuição dos vírus identificados pela vigilância sentinela do Distrito Federal, por SE, 2026
Fonte: SIVEP-Gripe.

Casos de SRAG sobem 5,9% no Distrito Federal nas SE 39 a 42 de 2026, com mais casos na Região Sudoeste

289	73	36,3%
casos de SRAG no DF nas SE 39 a 42	casos na Região Sudoeste, a maior do DF	maior alta, na Região Central
alta de 5,9%	**alta de 15,8%**	

Os casos de SRAG por região de saúde do Distrito Federal tiveram comportamento heterogêneo entre as SE 39 e 42, em comparação com o intervalo das SE 38 a 41: houve aumento em quatro regiões, queda em duas e estabilidade em uma. A Região Sudoeste passou a ter o maior número de casos nas últimas quatro semanas, 73, com aumento de 15,8%, seguida da Região Oeste (64 casos, estável) e da Centro-Sul (46 casos, queda de 4,7%). Os maiores aumentos percentuais ocorreram nas regiões Central (36,3%) e Leste (18,7%), seguidas da Sudoeste (15,8%) e da Sul (9,3%). A maior redução foi na Região Norte (21,4%). No total, o DF registrou 289 casos nas últimas quatro semanas, contra 273 no intervalo anterior, aumento de 5,9%. Esses números ainda podem aumentar, pois a notificação tem atraso natural: o agravamento da síndrome gripal costuma ocorrer algum tempo depois dos primeiros sintomas. (Figura 8; Tabela 1)

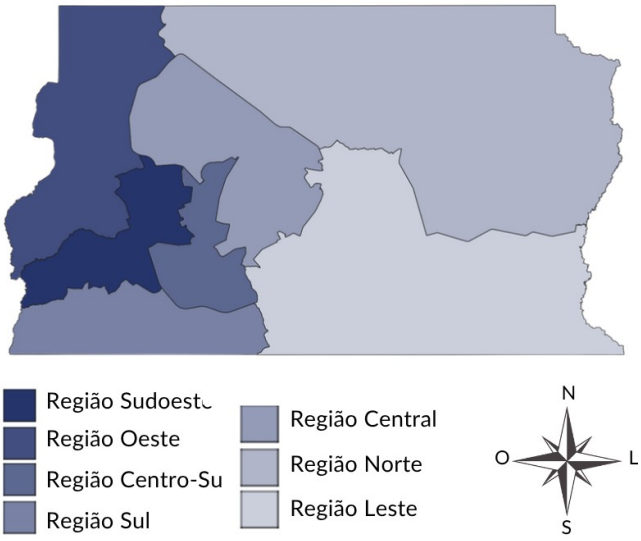


Figura 8. Casos de SRAG por região de saúde do Distrito Federal, SE 39 a 42 de 2026
Fonte: SIVEP-Gripe.

Tabela 1. Casos de SRAG por região de saúde, Distrito Federal, SE 39 a 42 de 2026

REGIÃO DE SAÚDE	SE 39	SE 40	SE 41	SE 42	TOTAL	VARIAÇÃO*
Sudoeste	22	13	18	20	73	alta de 15,8%
Oeste	21	14	14	15	64	estável
Centro-Sul	18	16	9	3	46	queda de 4,7%
Sul	8	10	7	10	35	alta de 9,3%
Central	6	7	8	9	30	alta de 36,3%
Norte	10	7	4	1	22	queda de 21,4%
Leste	8	6	3	2	19	alta de 18,7%
Total	**93**	**73**	**63**	**60**	**289**	**alta de 5,9%**

*Variação em relação ao intervalo das SE 38 a 41.

Guajará (AM) tem a maior incidência de SRAG do Amazonas na SE 43 de 2026, com 139,4 casos prováveis por 100 mil habitantes

139,4
casos por 100 mil hab. em Guajará, a maior incidência

44
casos prováveis em Eirunepé, o maior número absoluto

No Amazonas, os municípios com maior incidência de casos prováveis de SRAG são todos de pequeno porte. Guajará lidera, com 20 casos prováveis e taxa de 139,4 por 100 mil habitantes, em um município de pouco mais de 14 mil habitantes. Em seguida vêm Barcelos, com 25 casos e 137,2 por 100 mil, e Ipixuna, com 34 casos e 132,6 por 100 mil. Eirunepé aparece em quarto lugar, com 44 casos prováveis e taxa de 122,9 por 100 mil: é o maior número absoluto de casos entre os quatro, mas com taxa menor por ter população maior, de cerca de 36 mil habitantes. (Figura 9; Tabela 2)

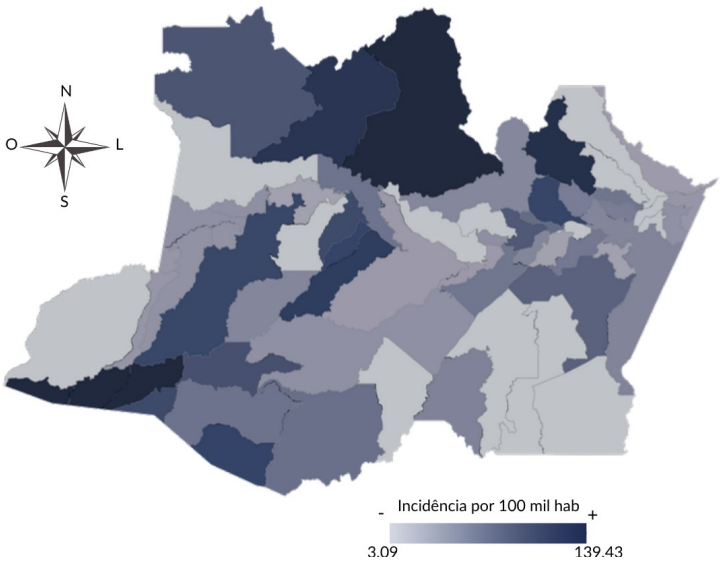


Figura 9. Incidência de SRAG por município de residência, Amazonas, SE 43 de 2026
Fonte: FVS-RCP/AM.

Tabela 2. Municípios do Amazonas com maior incidência de casos prováveis de SRAG, SE 43 de 2026

MUNICÍPIO	POPULAÇÃO	CASOS PROVÁVEIS	POR 100 MIL HAB.
Guajará	14.356	20	139,4
Barcelos	18.831	25	137,2
Ipixuna	25.792	34	132,6
Eirunepé	36.027	44	122,9

3 Cobertura vacinal

RISCO 0
Humanos

Maioria dos municípios do DF e da RIDE-DF tem cobertura vacinal contra influenza de 41% a 60% em crianças e idosos em 2026

41% a 60%
cobertura na maioria dos municípios, em crianças e idosos

21% a 40%
faixa de municípios no centro e leste da região

> 95%
meta ótima, alcançada por mais municípios entre gestantes

A cobertura vacinal contra influenza em três grupos prioritários do Distrito Federal e dos municípios da RIDE-DF (crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes e idosos) segue desigual em 2026. Em crianças e idosos, a maioria dos municípios situa-se na faixa de 41% a 60%, com um conjunto de municípios na faixa de 21% a 40% concentrado na porção central e leste da região. Em gestantes, o padrão é mais favorável, com maior número de municípios na meta ótima, acima de 95%, o que indica melhor alcance da vacinação nesse grupo. A heterogeneidade entre municípios é o principal achado: aqueles com cobertura abaixo de 40% em crianças e idosos concentram o maior risco de hospitalização e óbito por influenza, por se tratar de grupos com maior probabilidade de complicações respiratórias. (Figura 10)

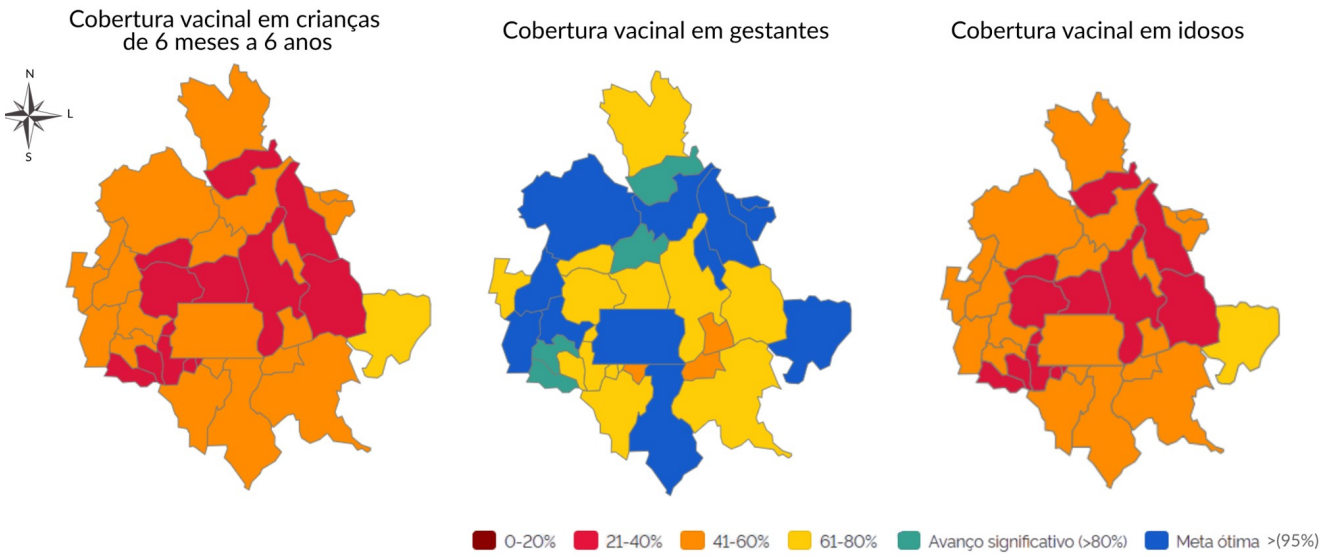


Figura 10. Cobertura vacinal contra influenza em crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes e idosos, Distrito Federal e RIDE-DF, 2026
Fonte: Ministério da Saúde.

4 Mpox

RISCO 4

Humanos e primatas não humanos

Zona Sul concentra 46 casos confirmados de mpox no município do Rio de Janeiro em 2026

46	23	20
casos na Zona Sul	casos em Penha/Ramos/Ilha	casos no Centro

A distribuição espacial dos casos confirmados de mpox no município do Rio de Janeiro em 2026 mostra a Zona Sul na liderança, com 46 casos, seguida de Penha/Ramos/Ilha, com 23, e do Centro, com 20. Em seguida aparecem Barra/Jacarepaguá, com 18 casos, e Campo Grande, com 12. A Zona Sul concentra sozinha o dobro de casos da segunda área, o que indica onde a vigilância e as ações de prevenção e vacinação devem ser mais intensas. (Figura 11; Tabela 3)



Figura 11. Distribuição espacial dos casos confirmados de mpox por área de residência, município do Rio de Janeiro, 2026
Fonte: EpiRio.

Tabela 3. Áreas de residência com mais casos confirmados de mpox, município do Rio de Janeiro, 2026

ÁREA DE RESIDÊNCIA	CASOS CONFIRMADOS
Zona Sul	46
Penha/Ramos/Ilha	23
Centro	20
Barra/Jacarepaguá	18
Campo Grande	12

Município do Rio de Janeiro soma 167 casos confirmados de mpox até a SE 43 de 2026, 96,4% em homens

167	81	96,4%	50,9%
casos confirmados	casos suspeitos	dos casos em homens	dos casos entre 30 e 39 anos

Os dados de mpox no município do Rio de Janeiro somam 167 casos confirmados até a SE 43 de 2026, além de 81 casos suspeitos em investigação. O perfil é predominantemente masculino, com 161 casos (96,4%) em homens e 6 (3,6%) em mulheres, e concentrado em adultos jovens: a faixa de 30 a 39 anos responde por 50,9% dos casos, seguida das de 18 a 29 anos (28,7%) e de 40 a 49 anos (17,4%). Os homens de 18 a 49 anos formam, portanto, o grupo que mais precisa de atenção à prevenção, ao diagnóstico precoce e à vacinação. (Figura 12)

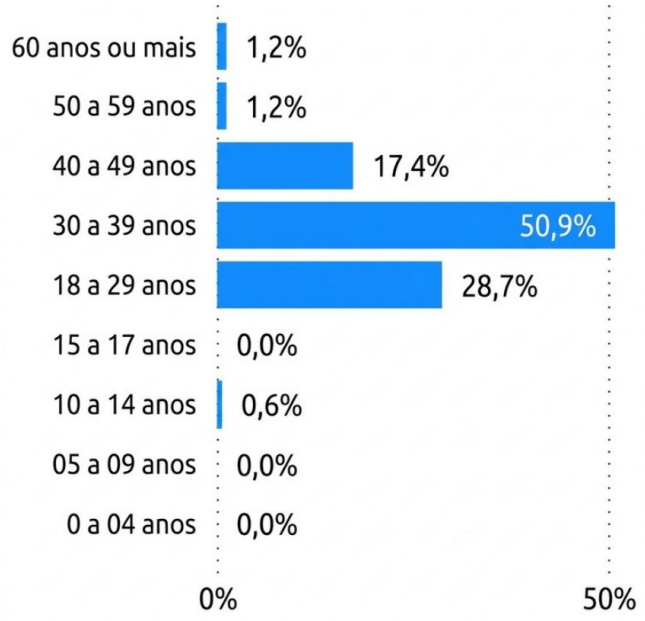


Figura 12. Casos confirmados de mpox por faixa etária, residentes no município do Rio de Janeiro, até a SE 43 de 2026
Fonte: EpiRio.

5 Arboviroses

RISCO 2
Humanos

Brasil registra 25.611 casos prováveis de dengue e 1 óbito entre as SE 39 e 42 de 2026

25.611	264	1
casos prováveis	casos graves	óbito
alta de 4,3%	alta de 2,6%	

Entre as SE 39 e 42 de 2026, o Brasil registrou 25.611 casos prováveis de dengue, aumento de 4,3% em relação ao intervalo das SE 38 a 41. Foram identificados 264 casos graves, alta de 2,6% na mesma base de comparação, e 1 óbito. A incidência de casos prováveis por 100 mil habitantes é heterogênea no território nacional, com expressiva concentração na Região Centro-Oeste, onde as taxas alcançam até 60 casos por 100 mil habitantes. Comportamento espacial semelhante é observado nos casos graves por 100 mil habitantes e na letalidade em casos graves, que chega a 12% em áreas pontuais do país. Esses dados reforçam a importância de manter a vigilância epidemiológica e entomológica em alerta e de priorizar a capacitação contínua das redes de saúde para o diagnóstico precoce e o manejo clínico oportuno, essenciais para conter a evolução para formas graves e evitar óbitos. (Figura 13)

A Incidência de casos prováveis por 100 mil hab.

B Incidência de casos graves por 100 mil hab.

C Letalidade em casos graves de dengue (%)

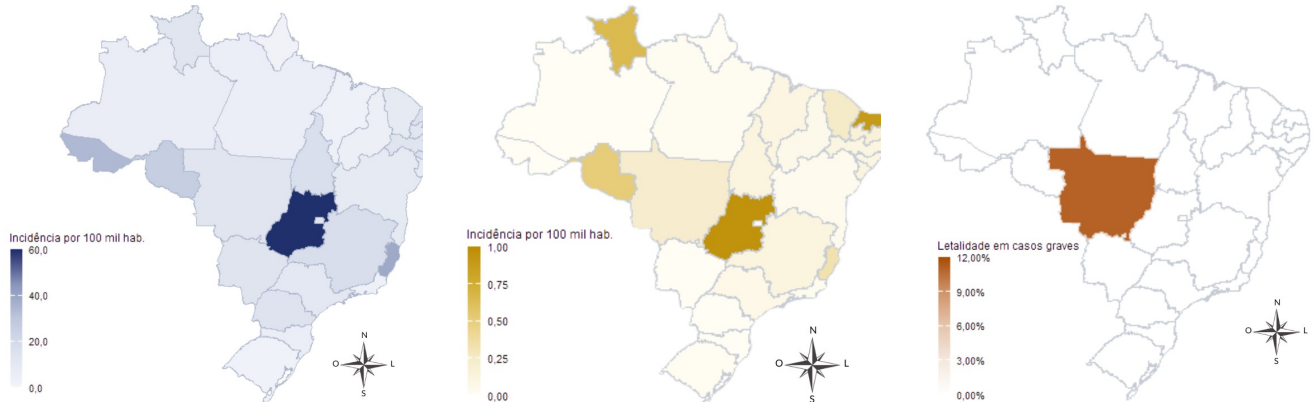


Figura 13. Incidência de casos prováveis e de casos graves de dengue por 100 mil habitantes e letalidade em casos graves, por UF, Brasil, SE 39 a 42 de 2026

Fonte: Ministério da Saúde.

Goiás registra 6.564 casos prováveis de dengue nas SE 39 a 42 de 2026, com maior incidência em Campestre de Goiás

6.564
casos prováveis
alta de 4,2%

87,6
casos por 100 mil hab.

1.341
casos por 100 mil hab. em Campestre de Goiás
alta de 147,6%

Em Goiás, entre as SE 39 e 42 de 2026, foram registrados 6.564 casos prováveis de dengue, incidência de 87,6 por 100 mil habitantes e aumento de 4,2% em relação ao período anterior. O cenário estadual reflete a pressão observada no Centro-Oeste no panorama nacional. A desagregação municipal evidencia forte heterogeneidade na transmissão local: Campestre de Goiás lidera, com 1.341 casos por 100 mil habitantes e aumento de 147,6%. Completam as primeiras posições Urutaí, Bela Vista de Goiás, Panamá e Mineiros, com incidências entre 432 e 459 casos por 100 mil habitantes. O panorama reforça a necessidade de direcionar ações coordenadas de controle vetorial e de atenção primária aos municípios com as maiores taxas de incidência. (Figura 14; Tabela 4)

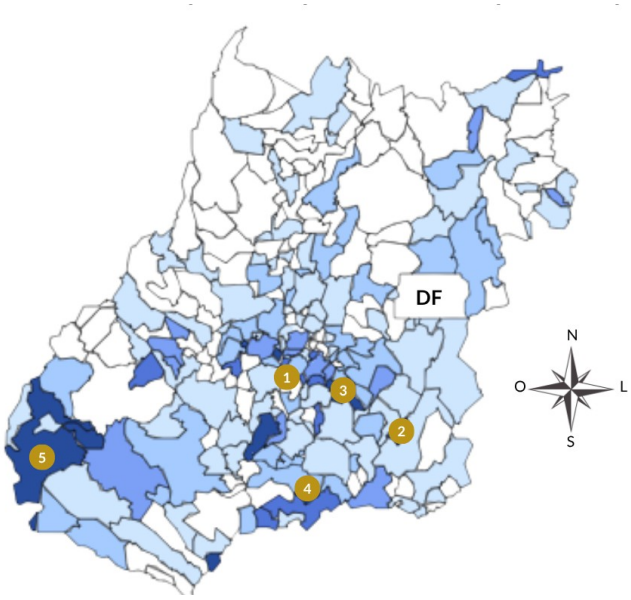


Figura 14. Incidência de casos prováveis de dengue por município, Goiás, SE 39 a 42 de 2026
Fonte: SES-GO.

Tabela 4. Municípios de Goiás com maior incidência de casos prováveis de dengue, SE 39 a 42 de 2026

MUNICÍPIO	POPULAÇÃO	CASOS PROVÁVEIS	VARIAÇÃO*	POR 100 MIL HAB.
Campestre de Goiás	3.879	52	alta de 147,6%	1.341
Urutaí	3.700	17	alta de 21,4%	459
Bela Vista de Goiás	37.305	169	alta de 8,3%	453
Panamá	2.432	11	queda de 31,2%	452
Mineiros	74.999	324	alta de 1,89%	432

*Variação em relação ao intervalo anterior.

Distrito Federal acumula 3.652 casos prováveis de dengue em 2026, sem óbitos, até a SE 42

3.652	231	16	0
casos prováveis	casos confirmados	casos com sinais de alarme	óbitos
alta de 1,6%			

No Distrito Federal, até a SE 42 de 2026, foram acumulados 3.652 casos prováveis de dengue, crescimento de 1,6% em relação à semana anterior. Do total, 231 casos têm confirmação laboratorial ou clínico-epidemiológica, 16 pacientes apresentaram sinais de alarme e não há óbitos. A incidência entre as SE 39 e 42 varia bastante entre as regiões administrativas (RAs). As maiores incidências estão em Sol Nascente/Pôr do Sol (51,10 por 100 mil hab.), Ceilândia (50,45), Gama (50,31), Fercal (42,09) e Santa Maria (35,42), na faixa mais alta do mapa, enquanto a área central, incluindo o Plano Piloto, apresenta os menores coeficientes (0,0 a 2,8 por 100 mil hab.). Esses pontos críticos de transmissão demandam atenção focalizada da gestão local. (Figura 15)

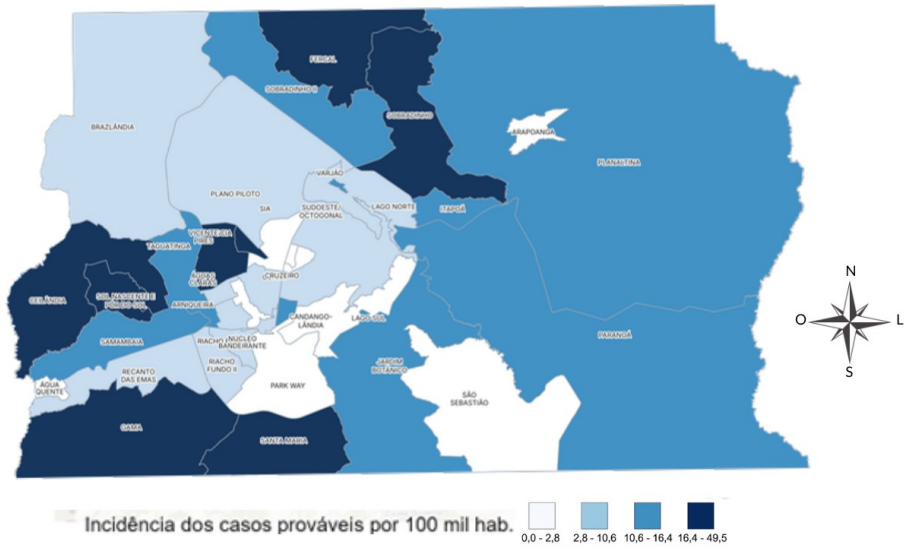


Figura 15. Incidência de casos prováveis de dengue por região administrativa, Distrito Federal, SE 39 a 42 de 2026
Fonte: SES-DF.

Brasil registra 2.719 casos prováveis de chikungunya nas SE 39 a 42 de 2026, com alta de 35,1% em Mato Grosso do Sul

2.719
casos prováveis
alta de 4,3%

22,5
casos por 100 mil hab. em Mato Grosso do Sul
alta de 35,1%

Entre as SE 39 e 42 de 2026, o Brasil registrou 2.719 casos prováveis de chikungunya, aumento de 4,3% em relação ao intervalo anterior. Mato Grosso do Sul lidera o coeficiente de incidência, com 22,5 casos por 100 mil habitantes (652 casos prováveis), e registra alta de 35,1%. Bahia (516 casos; 3,5 por 100 mil hab.), Alagoas (87 casos; 2,7), Pernambuco (213 casos; 2,2) e Rio Grande do Norte (70 casos; 2,0) aparecem em seguida entre as maiores incidências, mas todos com tendência de queda no período, entre 7,9% e 25,0%. A dinâmica evidencia um foco de aceleração concentrado no Centro-Oeste, em contraste com o arrefecimento das notificações nos principais pontos do Nordeste. (Figura 16; Tabela 5)

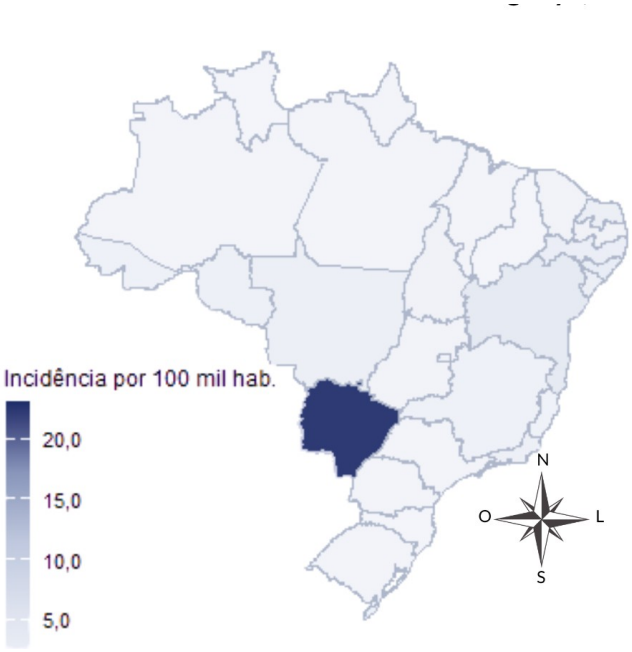


Figura 16. Coeficiente de incidência de casos prováveis de chikungunya por UF, Brasil, SE 39 a 42 de 2026
Fonte: Ministério da Saúde.

Tabela 5. UFs com maior incidência de casos prováveis de chikungunya, SE 39 a 42 de 2026

UF	CASOS PROVÁVEIS	POR 100 MIL HAB.	VARIAÇÃO*
Mato Grosso do Sul	652	22,5	alta de 35,1%
Bahia	516	3,5	queda de 7,9%
Alagoas	87	2,7	queda de 25,0%
Pernambuco	213	2,2	queda de 12,0%
Rio Grande do Norte	70	2,0	queda de 13,0%

*Variação em relação ao intervalo das SE 38 a 41.

RIDE-DF registra 391 casos prováveis de dengue nas SE 39 a 42 de 2026, com Planaltina (GO) e Formosa (GO) em destaque

391	6.029	5	213
casos prováveis de dengue nas SE 39 a 42	casos prováveis de dengue em 2026	casos prováveis de chikungunya nas SE 39 a 42	casos prováveis de chikungunya em 2026

Na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF), a dengue soma 6.029 casos prováveis acumulados em 2026, com 391 casos prováveis entre as SE 39 e 42. As maiores incidências no período estão em Planaltina (GO), com 45,6 por 100 mil habitantes e alta de 18,2%, Formosa (GO), com 45,6 por 100 mil e alta de 8,0%, e Cocalzinho de Goiás (GO), com 43,3 por 100 mil e queda de 7,7%. A chikungunya contabilizou apenas 5 casos prováveis no mesmo intervalo (213 no acumulado do ano), com notificações pontuais em Goianésia (GO), com 2,5 por 100 mil habitantes, Novo Gama (GO), com 1,8, e Unaí (MG), com 1,1. Os dados mostram que a dengue permanece como o principal agravo responsável pela carga de morbidade nos municípios do Entorno do DF. (Figura 17)

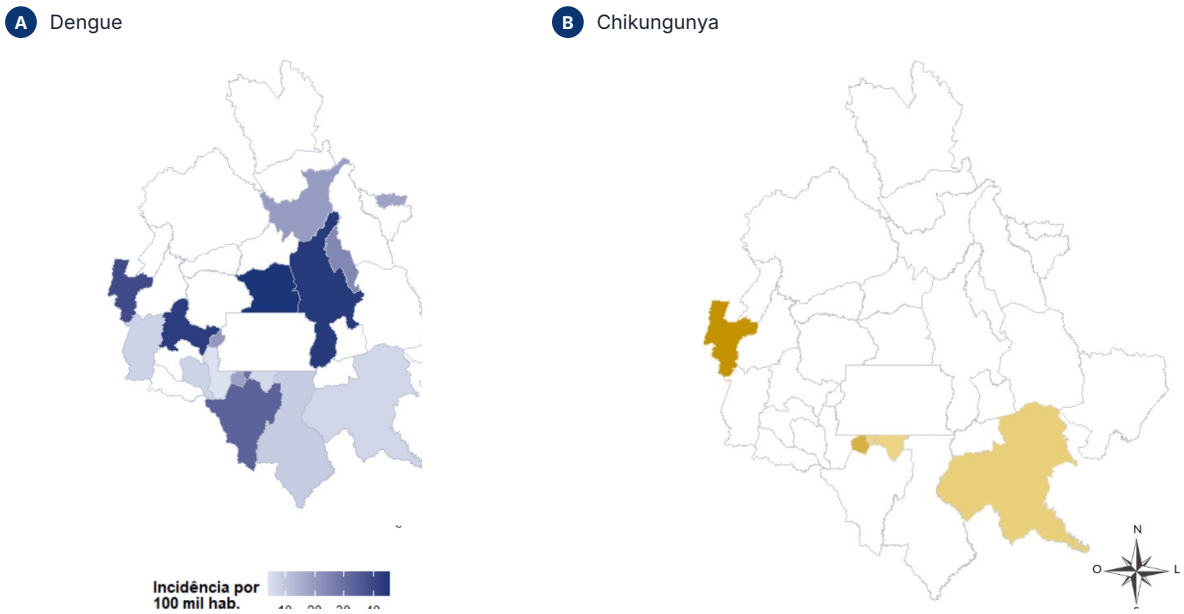


Figura 17. Incidência de casos prováveis de dengue e de chikungunya na RIDE-DF, SE 39 a 42 de 2026
Fonte: Ministério da Saúde.

6 Sarampo

RISCO 4

Humanos

Região das Américas acumula 56.978 casos de sarampo e 83 óbitos em 2026 até a SE 42

56.978	83	> 93%
casos confirmados em 2026	óbitos	dos casos na Guatemala, no México e nos EUA

Até a SE 42 de 2026, a Região das Américas acumula 56.978 casos confirmados de sarampo e 83 óbitos. Guatemala (34.535 casos, 53 óbitos), México (13.761 casos, 23 óbitos) e Estados Unidos (4.852 casos, 5 óbitos) concentram mais de 93% do total regional. Peru (2.805 casos) e Canadá (1.124) formam o segundo grupo em volume. Entre os vizinhos do Brasil, o Peru tem a maior carga, seguido da Bolívia (120 casos, 1 óbito, última SE informada 39); a Colômbia registra 16 casos e o Brasil, 61. A última semana informada varia da SE 15 à SE 41 entre os países, o que pode refletir atraso de notificação ou datas de corte diferentes e compromete comparações diretas; a OPAS registra o Brasil até a SE 40, enquanto o Ministério da Saúde divulga dados até a SE 42. A mortalidade por sarampo também varia muito entre os países, e Guatemala e México respondem por mais de 80% dos óbitos regionais. (Figura 18; Tabela 6)

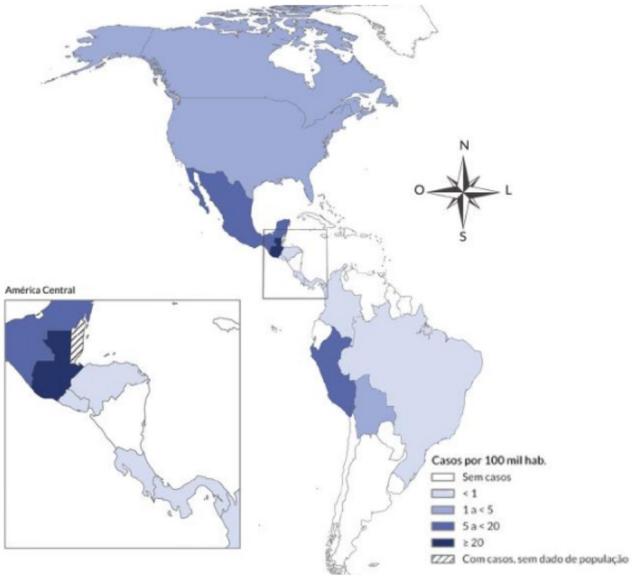


Figura 18. Casos acumulados confirmados de sarampo e coeficiente de incidência por 100 mil habitantes, Região das Américas, SE 1 a 42 de 2026

Fonte: OPAS, CDC, PA DOH, DGE/SSA, Minsa/DGE, PHAC, MSPAS, Minsalud e Ministério da Saúde.

Tabela 6. Casos confirmados e óbitos por sarampo na Região das Américas, 2026

PAÍS	CONFIRMADOS	ÚLTIMA SE	ÓBITOS
Guatemala	34.535	41	53
México	13.761	40	23
Estados Unidos	4.852	41	5
Peru	2.805	40	1
Canadá	1.124	40	0
Bolívia	120	39	1
Brasil	61	40	0
El Salvador	58	30	0
Colômbia	16	38	0
Honduras	15	31	0
Belize	15	31	0
Panamá	9	23	0
Costa Rica	5	15	0
Outros	5		0
Total	**56.978**		**83**

Total conforme o slide do SITREP.

Estados Unidos acumulam 4.852 casos de sarampo e 5 óbitos em 2026, com 264 casos nas SE 41 e 42

4.852
casos confirmados
alta de 5,7% (264 casos)

5
óbitos

Os Estados Unidos registram 4.852 casos confirmados de sarampo em 2026, com 5 óbitos, o que resulta em letalidade inferior a 0,11%. A curva por semana de início do exantema evidencia dois períodos distintos: um pico próximo de 300 casos semanais no fim de 2025, seguido de um platô entre 30 e 60 casos semanais de março a julho de 2026, e uma segunda elevação a partir de agosto, com valores próximos de 240 casos por semana em agosto e setembro. Essa reativação após um intervalo de baixa incidência é o aspecto mais relevante da série, pois aponta para novas cadeias de transmissão, e não apenas para a persistência de focos antigos. As duas últimas semanas mostram queda parcial, que deve ser interpretada à luz do atraso entre o início do exantema e a notificação, que pode chegar a algumas semanas. Os 264 casos das SE 41 e 42 correspondem a 5,7% do acumulado, o que confirma transmissão ativa, embora em intensidade inferior ao pico de agosto. A distribuição por jurisdição é desigual, com concentração em alguns estados e ausência de casos em outros, e a declaração de emergência em parte deles indica resposta conduzida também no nível estadual. (Figura 19)

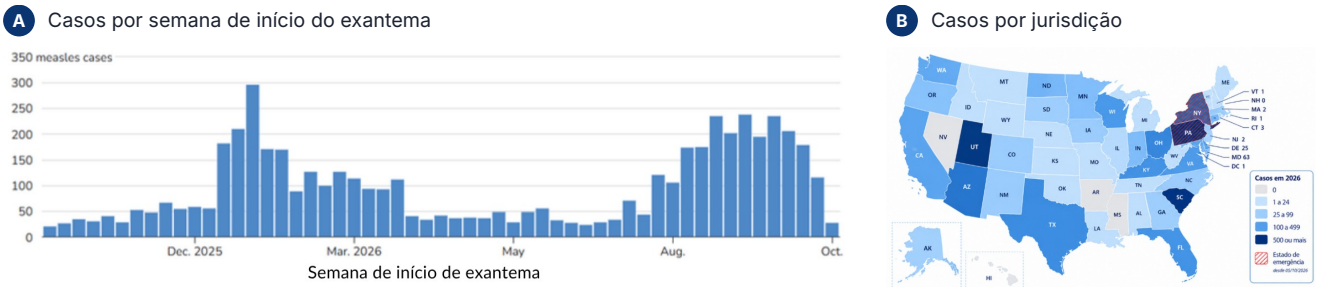


Figura 19. Casos confirmados de sarampo por semana de início do exantema e por jurisdição, Estados Unidos, 2026
Fonte: CDC.

Pensilvânia (EUA) soma 1.338 casos de sarampo e 5 óbitos em 2026, com 88 casos nas SE 41 e 42

1.338	5	27,6%
casos confirmados	óbitos	do total de casos dos EUA
alta de 6,6% (88 casos)		

A Pensilvânia acumula 1.338 casos confirmados de sarampo e 5 óbitos em 2026, cerca de 27,6% do total nacional, o que a coloca entre os principais focos do país. A curva por semana cresce a partir de junho, acelera em julho e agosto, atinge pico de aproximadamente 143 casos na primeira semana de setembro e declina nas semanas seguintes. Esse padrão de ascensão e queda é consistente com a dinâmica de surtos em populações com cobertura vacinal heterogênea, nas quais a transmissão se reduz quando a proporção de suscetíveis cai abaixo do limiar efetivo. A última semana é parcial, de modo que o valor de cerca de 10 casos não representa queda real. As SE 41 e 42 somam 88 casos, ou 6,6% do acumulado estadual, o que indica ritmo recente bem abaixo do pico. A distribuição por condado é heterogênea, com maior densidade de casos no centro e no sudeste do estado. (Figura 20)

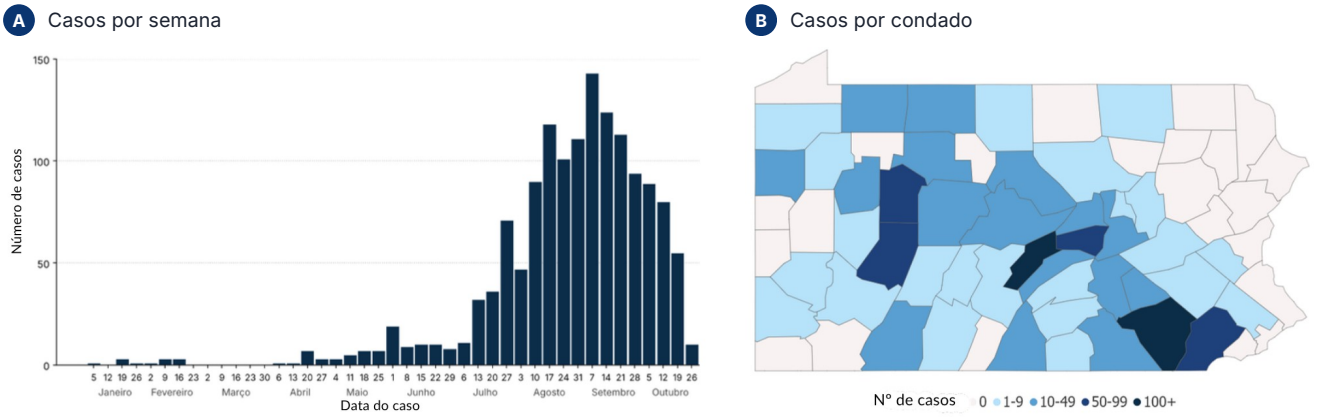


Figura 20. Casos confirmados de sarampo por semana e por condado, Pensilvânia (EUA), 2026
Fonte: Pennsylvania Department of Health (PA DOH).

México soma 13.761 casos e 23 óbitos por sarampo em 2026, em fase de baixa transmissão

13.761	23	106%
casos confirmados **alta de 0,2% (39 casos)**	óbitos, letalidade de 0,17%	de aumento em relação a 2025

O México registra 13.761 casos confirmados de sarampo e 23 óbitos até a SE 42 de 2026, com letalidade de cerca de 0,17%. A curva semanal atinge pico próximo de 1.300 casos na SE 6, seguido de declínio progressivo, e apresenta valores baixos a partir da SE 27, o que caracteriza a fase de controle do surto principal. Nas duas últimas semanas foram registrados 39 casos, equivalentes a 0,2% do total. O acumulado de 2026 supera em 106% os 6.664 casos de 2025 e situa o país entre os de maior carga da região. A incidência por município é mais elevada em estados do norte e do centro-norte, padrão que sugere focos regionais com cadeias próprias, e não disseminação uniforme. A persistência de casos esparsos entre as SE 30 e 40 indica transmissão residual, capaz de se reacender em áreas com cobertura abaixo da meta, e requer vigilância contínua dos casos suspeitos e de seus contatos. (Figura 21)

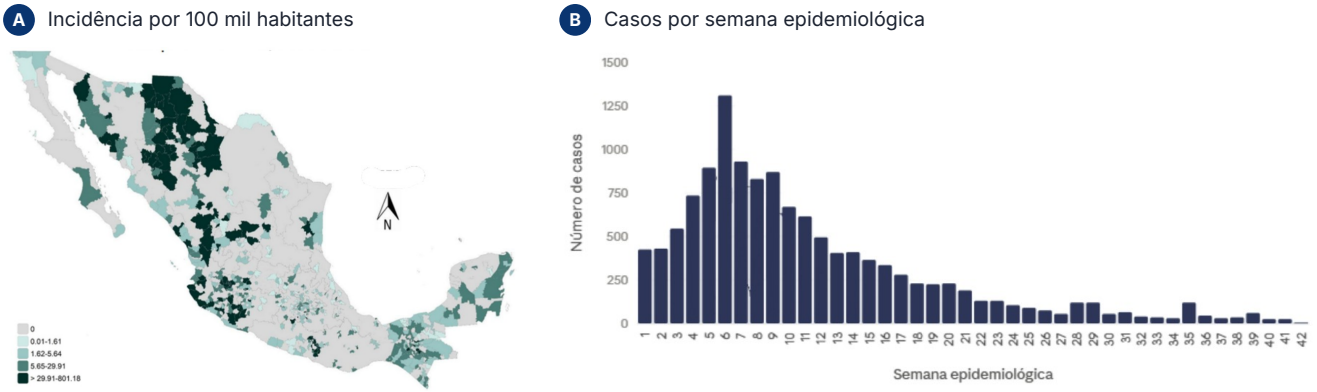


Figura 21. Incidência de casos confirmados de sarampo por município e casos por semana epidemiológica, México, 2026
Fonte: Gobierno de México.

Peru registra 2.805 casos de sarampo em 2026 até a SE 42, com Loreto como principal ponto de contato com o Brasil

2.805	1	> 1.000
casos confirmados **alta de 3,5% (96 casos)**	óbito	casos em Puno

O Peru registra 2.805 casos confirmados de sarampo em 2026 até a SE 42, com 1 óbito, o que corresponde a letalidade de cerca de 0,04%, muito abaixo da observada na Guatemala e no México. A curva por semana de início do exantema mostra início do surto na SE 12, elevação rápida até a SE 20 e platô entre 100 e 150 casos semanais das SE 20 a 37, com pico de aproximadamente 156 casos na SE 36. A partir da SE 38, há queda progressiva até cerca de 6 casos na SE 42. O platô prolongado, em vez de pico agudo, sugere transmissão sustentada e disseminada por várias semanas, e não apenas introduções pontuais. Os 96 casos das SE 41 e 42 correspondem a 3,5% do acumulado, mas as semanas posteriores à SE 42 não têm atualização de dados, o que torna a queda final pouco interpretável. A carga se concentra no sul do país: Puno, com 1.000 casos ou mais, e Arequipa, na faixa de 201 a 999, respondem por parcela expressiva do total, mas nenhum dos dois faz fronteira com o Brasil. Loreto, que faz fronteira com o Amazonas, está em faixa interme-

diária, de 51 a 200 casos, e é o principal ponto de contato com o território brasileiro. O risco de importação para o Brasil decorre, assim, de um foco amazônico de menor magnitude, e não do principal foco andino, o que é consistente com os casos registrados em Tabatinga e Benjamin Constant. (Figura 22)

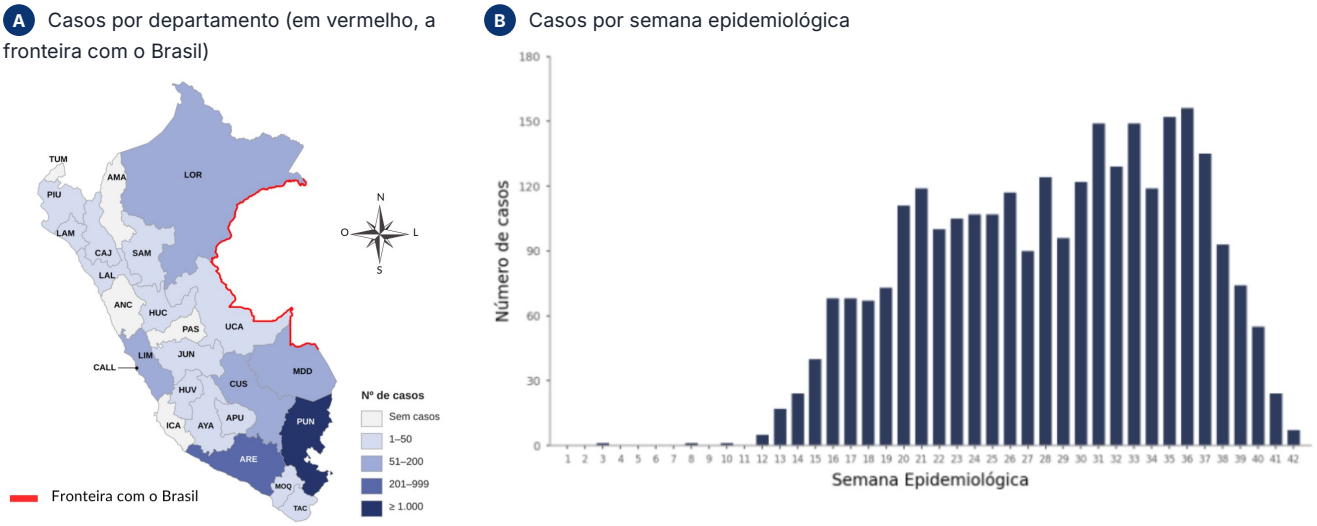


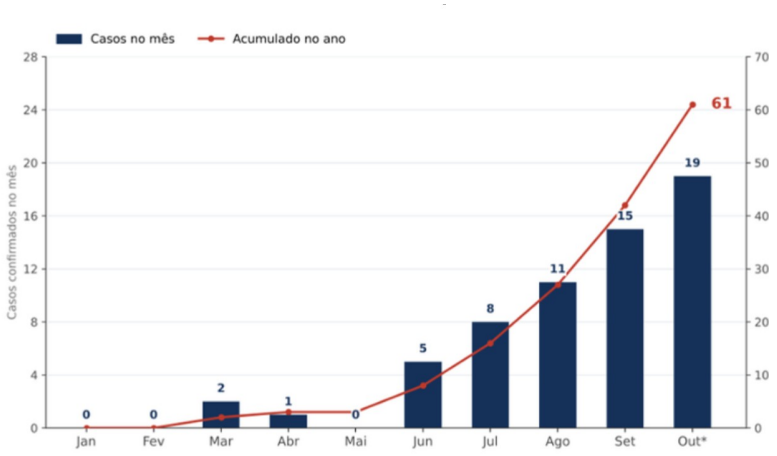
Figura 22. Casos de sarampo por departamento e por semana epidemiológica, Peru, 2026
Fonte: Ministerio de Salud del Perú.

Brasil confirma 61 casos de sarampo até a SE 42 de 2026, com surtos ativos em São Paulo e no Amazonas

61	41	17	0
casos confirmados	casos em São Paulo	casos no Amazonas	óbitos

O Brasil acumula 61 casos confirmados de sarampo até a SE 42 de 2026, sem óbitos. A série mensal registra 2 casos em março, 1 em abril, nenhum em maio, 5 em junho, 8 em julho, 11 em agosto, 15 em setembro e 19 em outubro (até o dia 19). O incremento médio de cerca de 36% ao mês entre julho e setembro confirma a aceleração desde junho, com padrão de crescimento compatível com transmissão local sustentada. O caso de fevereiro, com início de sintomas em 8 de fevereiro, aparece em março, o que indica contagem pela data de confirmação, e não pela de início dos sintomas, aspecto relevante para o cálculo de intervalos entre casos. A distribuição é de 41 casos em São Paulo, 17 no Amazonas, 2 no Acre e 1 no Rio de Janeiro, e os casos do Amazonas e do Acre estão ligados a surtos originados no Peru. O Ministério da Saúde informa 44 casos associados a surtos ativos e 17 a surtos encerrados. A OPAS, com dados até 3 de outubro, mantém o país no cenário de importações esporádicas, classificação divergente da adotada pelo Ministério, o que deve ser interpretado com cautela em função da data de corte. (Figura 23)

A Casos por mês e acumulado no ano



B Distribuição dos casos por UF

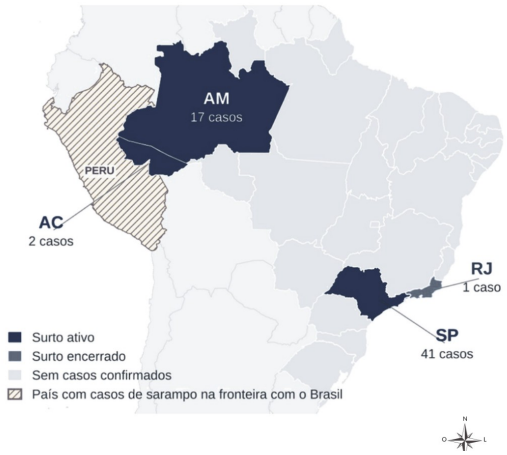


Figura 23. Casos confirmados de sarampo por mês e distribuição dos casos por UF, Brasil, 2026
Fonte: Ministério da Saúde.

Nenhuma região do Brasil atinge a meta de 95% de cobertura da segunda dose contra o sarampo em 2026

73,3%	82,2%	97%
menor cobertura da 2ª dose, Região Norte	maior cobertura da 2ª dose, Região Sul	proteção conferida por duas doses

A cobertura da primeira dose contra o sarampo atinge a meta ótima de 95% apenas no Sudeste (95,5%) e no Sul (96,5%). Norte (91,4%), Nordeste (94,2%) e Centro-Oeste (94,7%) permanecem abaixo desse limiar, com o Norte em situação mais desfavorável. Na segunda dose, nenhuma região alcança 95%: Norte 73,3%, Nordeste 79,1%, Centro-Oeste 77,2%, Sudeste 81,8% e Sul 82,2%. A diferença entre a primeira e a segunda dose varia de 13,7 a 18,1 pontos percentuais, com maior distância no Norte (18,1) e no Centro-Oeste (17,5). Como duas doses conferem cerca de 97% de proteção, a lacuna na segunda dose representa a principal fragilidade da imunidade populacional, pois reduz a proporção de pessoas com esquema completo. (Tabela 7)

Tabela 7. Cobertura vacinal contra o sarampo por região, Brasil, 2026

REGIÃO	1ª DOSE	2ª DOSE	DIFERENÇA (PONTOS PERCENTUAIS)
Norte	91,4%	73,3%	18,1
Nordeste	94,2%	79,1%	15,1
Centro-Oeste	94,7%	77,2%	17,5
Sudeste	95,5%	81,8%	13,7
Sul	96,5%	82,2%	14,3

Meta de cobertura: 95%.

7 Ebola

RISCO 4

Humanos e primatas não humanos

República Democrática do Congo acumula 10.274 casos confirmados e 4.992 óbitos por doença pelo vírus Bundibugyo até 29 de outubro de 2026

10.274	4.992	1.052	87%
casos confirmados	óbitos	hospitalizados em isolamento	dos contatos em monitoramento
alta de 5,8%	alta de 6,5%		

A epidemia de doença pelo vírus Bundibugyo na República Democrática do Congo (RDC), declarada pela OMS em 15 de maio de 2026, mantém transmissão sustentada e de alta intensidade. Até 29 de outubro, foram confirmados 10.274 casos (alta de 5,8% em relação à semana anterior) e 4.992 óbitos (alta de 6,5%), com letalidade bruta de 48,6%, além de 2.595 recuperados; no último informe diário, somaram-se 78 casos novos. Há 1.052 pessoas hospitalizadas em isolamento. É o maior surto de doença pelo vírus Ebola já registrado no país, independentemente da espécie viral, e apenas o segundo causado pelo Bundibugyo, após o de 2012. O seguimento dos contatos alcança 87%, abaixo da meta de 95%. Não há vacina nem tratamento específico licenciados para essa espécie viral; em 23 de outubro, começou em Bunia o ensaio clínico de fase 2/3 TUMAINI, que avalia candidatas vacinais contra o Bundibugyo. A OMS classifica o risco como muito alto no país, alto para os países fronteiriços e baixo para o restante da região africana e em nível global. (Figura 24)

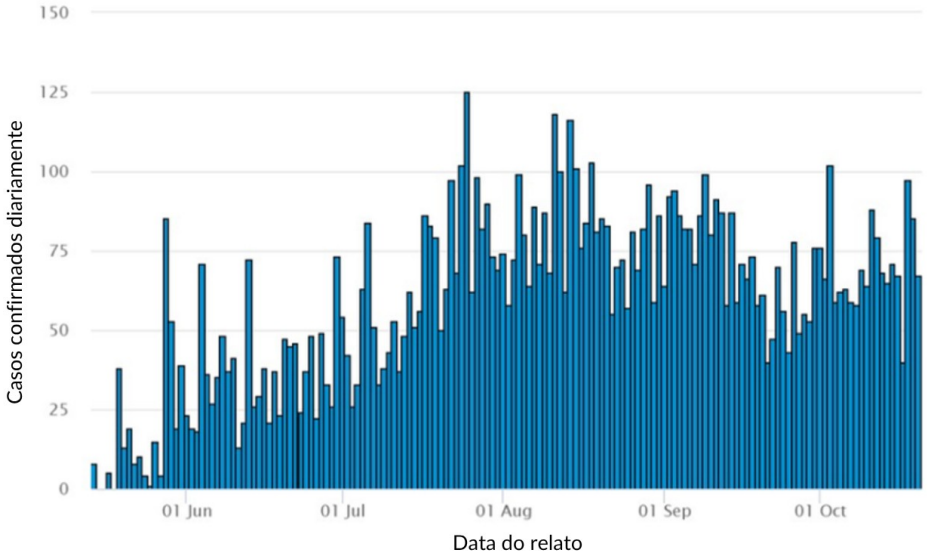


Figura 24. Casos confirmados de Ebola por data de notificação, República Democrática do Congo, maio a outubro de 2026
Fonte: MSPHP (RDC) e OMS.

Surto de Ebola atinge 67 zonas de saúde em oito províncias da República Democrática do Congo até 28 de outubro de 2026

67	8	56,1%
zonas de saúde afetadas	províncias afetadas	letalidade em Kivu do Norte, a maior do país

O surto de Ebola atinge 67 das 178 zonas de saúde (37,6%) em oito províncias da República Democrática do Congo, e 50 delas notificaram ao menos um caso nos últimos 21 dias. Ituri permanece como epicentro, com 7.318 casos confirmados e 3.418 óbitos, e 28 de suas 36 zonas de saúde (77,8%) afetadas; Mandima, Beni e Bunia concentram a maior carga recente. Kivu do Norte, com 2.391 casos e 1.341 óbitos, cresceu em ritmo semanal duas vezes maior que Ituri e tem a maior letalidade provincial, de 56,1%, o que pode refletir maior proporção de óbitos na comunidade e menor detecção de casos leves. Haut-Uélé (450 casos) e Tshopo (91 casos) seguem com transmissão ativa. Nord Ubangi tornou-se a oitava província afetada, com 6 casos e 1 óbito, e Dakwa, em Haut-Uélé, é a zona de saúde de introdução mais recente. Bas-Uélé, Kivu do Sul e Sud Ubangi não registraram casos novos no período. O avanço para o norte aproxima a transmissão das fronteiras com a República Centro-Africana e o Sudão do Sul, em um contexto de crise humanitária concomitante que dificulta o rastreamento de contatos e o acesso aos serviços de saúde. (Figura 25; Tabela 8)

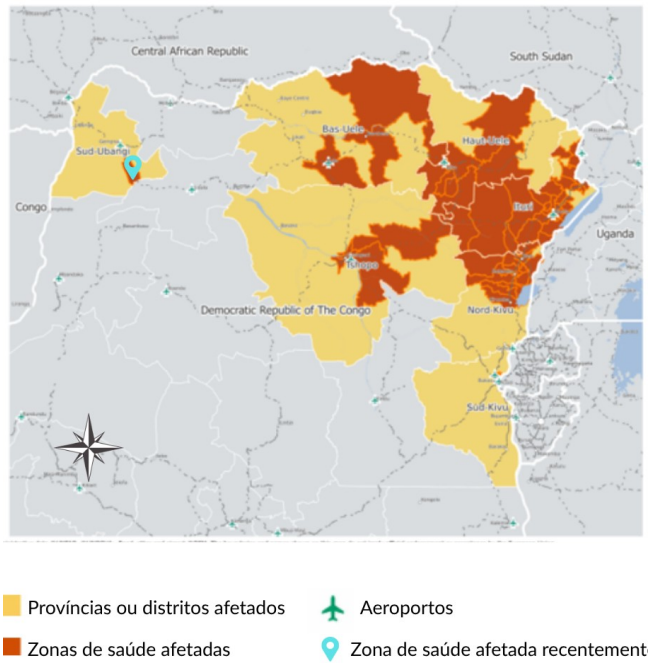


Figura 25. Áreas afetadas pelo surto de Ebola na República Democrática do Congo, outubro de 2026
Fonte: MSPHP (RDC) e ECDC.

Tabela 8. Casos, óbitos e letalidade por Ebola por província, República Democrática do Congo, até 28 de outubro de 2026

PROVÍNCIA	CASOS NOVOS (24H)	CASOS CONFIRMADOS	ÓBITOS CONFIRMADOS	LETALIDADE	ZONAS DE SAÚDE AFETADAS
Ituri	40	7.318	3.418	46,7%	28/36 (77,8%)
Kivu do Norte	30	2.391	1.341	56,1%	17/34 (50,0%)
Haut-Uélé	6	450	199	44,2%	7/13 (53,8%)
Tshopo	2	91	27	29,7%	7/23 (30,4%)
Kivu do Sul	0	3	1	33,3%	1/34 (2,9%)
Bas-Uélé	0	13	4	30,8%	4/11 (36,4%)
Sud Ubangi	0	2	1	50,0%	1/16 (6,3%)
Nord Ubangi	0	6	1	16,7%	2/11 (18,2%)
Total RDC	**78**	**10.274**	**4.992**	**48,6%**	**67/178 (37,6%)**

Dados atualizados até 28/10/2026.

Quênia e Nigéria somam 10 casos de Ebola e 2 óbitos fora da República Democrática do Congo em outubro de 2026

10	2	2
casos confirmados fora da RDC	óbitos, ambos no Quênia	países: Quênia e Nigéria

Em outubro, a epidemia ultrapassou a República Democrática do Congo com casos importados no Quênia e na Nigéria, ambos com trânsito pela Uganda em 3 de outubro. No Quênia, o caso índice chegou a Nairóbi por via aérea após cerca de um mês de doença, morreu em 5 de outubro e foi notificado no dia seguinte; em 23 de outubro, foi confirmado o segundo óbito, de uma familiar do caso índice, ainda não incorporado aos informes da OMS e do ECDC. Até 29 de outubro, o país somava nove casos e dois óbitos: o caso índice e oito secundários, quatro familiares e quatro profissionais de saúde, todos já em quarentena ao iniciar os sintomas, o que reduz a probabilidade de cadeias não identificadas; 135 contatos estão em quarentena. Na Nigéria, o caso de Abuja iniciou sintomas em 7 de outubro, quatro dias após a chegada, buscou atendimento em 11 de outubro e só foi confirmado em 20 de outubro. Esse intervalo de nove dias entre o atendimento e a confirmação amplia a janela de exposição em serviços de saúde; o paciente está em isolamento, 62 contatos estão em monitoramento e a investigação da fonte segue em andamento. A OMS mantém a recomendação contra restrições de viagem e comércio. (Figura 26)

03/10 — Os dois casos transitam pela Uganda

06/10 — Quênia notifica o 1º caso, já em óbito

07/10 — Início de sintomas do caso na Nigéria

20/10 — Nigéria confirma o caso

20/10 — Quênia chega a 9 casos

29/10 — Quênia soma 9 casos e 2 óbitos

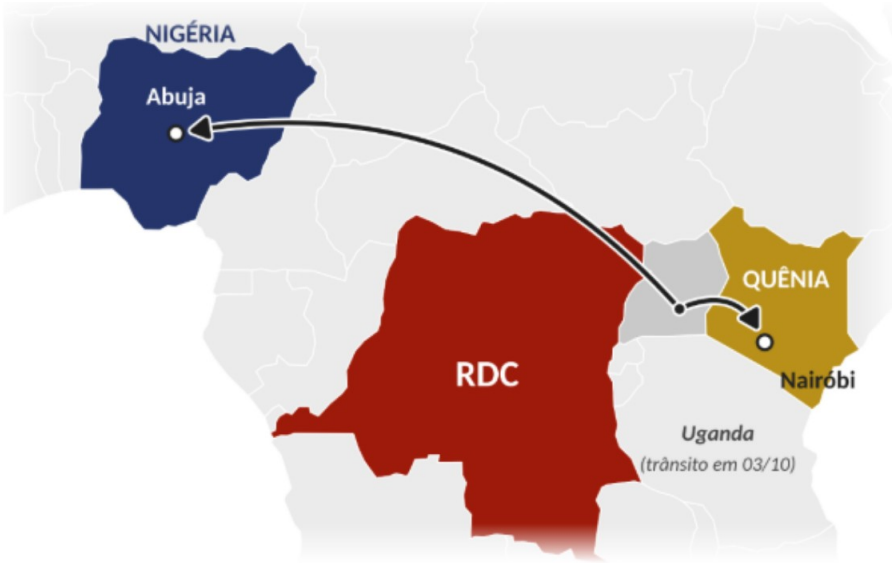


Figura 26. Casos de Ebola exportados da República Democrática do Congo para o Quênia e a Nigéria, com trânsito pela Uganda, outubro de 2026

Fonte: MSPHP (RDC) e OMS.

8 Atualidades

Secretaria de Saúde do Distrito Federal amplia a vacinação contra influenza a toda a população a partir de 6 meses em 29 de outubro de 2026

57,3%	+40 mil	2 doses
cobertura vacinal acumulada nos grupos prioritários **meta de 90%**	doses disponíveis no DF	para crianças de 6 meses a menores de 9 anos vacinadas pela 1ª vez

Em 29 de outubro de 2026, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal ampliou a vacinação contra a influenza para toda a população a partir de 6 meses de idade que ainda não foi vacinada em 2026, enquanto houver doses disponíveis. A medida considera que a cobertura vacinal acumulada entre idosos, gestantes e crianças de 6 meses a menores de 6 anos está em 57,3%, abaixo da meta de 90%, e que o DF tem mais de 40 mil doses em estoque. O esquema é de duas doses, com intervalo de 30 dias, para crianças de 6 meses a menores de 9 anos vacinadas pela primeira vez, e de dose única para quem já recebeu ao menos uma dose em anos anteriores e para as demais faixas etárias. A ampliação não deve comprometer a vacinação dos grupos prioritários (crianças, gestantes, puérperas, idosos, povos indígenas, trabalhadores da saúde e pessoas com comorbidades), e a busca ativa nesses grupos deve ser mantida.

Fonte: SES-DF.

Departamento de Saúde da Pensilvânia (EUA) alerta profissionais de saúde sobre sarampo congênito em outubro de 2026

1 em 3	10 dias	± 4 dias
bebês de mães com erupção nos 14 dias antes do parto desenvolve sarampo congênito	de vida, limite da definição de caso congênito	período de transmissão materna em torno da erupção

Em outubro de 2026, o Departamento de Saúde da Pensilvânia, nos Estados Unidos, emitiu alerta aos profissionais de saúde sobre o sarampo congênito, situação em que o bebê adquire a infecção da mãe ainda durante a gestação e que não era vista no estado havia décadas. O vírus é transmitido por via respiratória, de pessoa a pessoa, e por via transplacentária, da mãe para o feto. O alerta define como caso congênito o recém-nascido com sarampo clínico ou laboratorial até o 10º dia de vida e exposição intrauterina ao vírus. O risco é maior quando a erupção cutânea materna ocorre perto do parto: cerca de um em cada três bebês de mães com erupção nos 14 dias anteriores ao parto desenvolve a doença. A contagem parte do dia da erupção na mãe (dia 0); a gestante transmite o vírus de quatro dias antes a quatro dias depois da erupção, e no início o quadro pode parecer apenas uma gripe. O parto entre o início dos sintomas maternos e 14 dias após a erupção coloca o recém-nascido em risco: ele pode estar doente e transmitir o vírus e, por isso, deve ser isolado, testado e receber imunoglobulina. Passados mais de 14 dias da erupção, o bebê com 34 semanas ou mais de gestação não deve ter doença ativa nem transmitir o vírus, mas continua em acompanhamento, pois a infecção intrauterina pode causar complicações tardias. A principal forma de prevenção é a vacinação da mulher antes da gravidez, já que a vacina não pode ser aplicada durante a gestação.

Início dos sintomas
Começa a janela de risco para o recém-nascido

4 dias antes
A mãe passa a transmitir o vírus

Dia 0
Erupção cutânea na mãe

4 dias depois
Fim do período de transmissão materna

14 dias depois
Fim da janela de risco; depois, sem risco agudo para bebês com 34 semanas ou mais

Fonte: Pennsylvania Department of Health (PA-HAN 2026-842).

NOTA METODOLÓGICA

Boletim referente à SE 43/2026 (25 a 31 de outubro de 2026), elaborado a partir do relatório de situação (SITREP) semanal. As figuras reproduzem os painéis do relatório, com as fontes indicadas em cada uma. Os dados são preliminares e estão sujeitos a alteração; para uso técnico, consulte sempre a fonte original indicada.

ELABORAÇÃO

Alerta ambiental	Bárbara Gripp
Síndrome gripal	Anna Karolina
SRAG	Anna Karolina
Imunopreveníveis	Vitória Chagas
Arboviroses	Layane Rodrigues
Sarampo	Vitória Chagas
Ebola	Antônia Santos
Atualidades	Gustavo Manço
Mpox	Gustavo Manço
Revisão	Clara Feitosa, Jonas Brant

REALIZAÇÃO

Sala de Situação de Saúde - UnB
Residência de Vigilância em Saúde